

ITEM 349 : SYNDROME OCCLUSIF

Diagnostic positif	C	- Douleur abdominale - Arrêt des matières et des gaz (très spécifique) avec possible diarrhée par vidange passive du segment d'aval - Nausées ou vomissements : tardifs en cas d'obstruction basse - Météorisme abdominal : minime en cas d'obstruction haute - Retentissement : déshydratation, tachycardie, fièvre - Examen clinique : tympanisme, bruits hydro-aériques → Systématique : inspection des cicatrices abdominales, palpation des orifices herniaires et TR		
	PC	- ASP : niveaux hydro-aériques (sur ASP debout) ou distensions (sur ASP couché) grêliques et/ou coliques - TDM injecté: - Diagnostic : niveaux hydro-aériques, distension grêlique > 3 cm, colique > 6 cm ou caecale > 9 cm - Siège de l'obstacle : à la jonction entre intestin dilaté et intestin plat - Souffrance intestinale: absence de rehaussement et amincissement pariétal, pneumatose		
Etiologie	Obstacle mécanique	Intra-luminal	Pariétal	Extra-luminal
		- Fécalome - Bézoard : conglomérat d'aliments non digérés - Calcul - Parasite	- Cancer ou polype colorectal - Inflammatoire : MICI, tuberculose, ischémie, radique - Hématome - Invagination intestinale	- Brides post-opératoires - Volvulus - Hernie étranglée - Carcinose péritonéale - Tumeur ovarienne
	Occlusion fonctionnelle	= Touche le grêle et le colon, avec niveaux liquides à proximité de la zone pathologique ou diffus		
		Iléus réflexe	- Colique néphrétique, infection pleuro-pulmonaire, IDM, GEU, torsion d'annexe - Traumatisme : rachis, bassin - Hématome du psoas - Pancréatite, appendicite méso-coeliaque, péritonite, infarctus mésentérique	
Siège	Occlusion haute	Pseudo-obstruction intestinale	- Métabolique : hypercalcémie, hypokaliémie, acidose - Médicament : opiacé, anticholinergique, neuroleptique - Maladie systémique : hypothyroïdie, neuropathie (diabète...), sclérodermie... - Syndrome d'Ogilvie = colectasie aiguë idiopathique	
		= Siège sur le grêle, en amont de la valvule de Bauhin : - Début brutal avec douleurs vives, vomissements précoces et abondants, arrêt des matières et des gaz retardé, état général rapidement altéré, météorisme possiblement minime - ASP : - Debout : niveaux hydro-aériques multiples, centraux et plus larges que hauts - Couché : valvules conniventes (fines incisures d'un bord à l'autre de l'intestin dilaté) - TDM : obstacle à la partie proximale de l'intestin, feces sign (stagnation stercorale)		
Siège	Occlusion basse	= Siège sur le cadre colique ou le rectum ± étendu au grêle si la valvule de Bauhin n'est pas continente - Début discret, progressif avec douleurs peu intenses, vomissements rares et tardifs, puis fécaloïdes à un stade très tardif, arrêt net du transit, état général longtemps conservé, météorisme important en cadre - ASP : - Debout : niveaux hydro-aériques rares, périphériques et plus hauts que larges - Couché : hausturations (larges incisures asymétriques) - TDM : siège de l'obstacle, et souvent diagnostic étiologique (cancer, volvulus...)		
		= Etranglement de l'intestin et de son méso, avec risque de nécrose intestinale → urgence thérapeutique - Début brutal, sans prodrome : douleur vive, vomissements précoces, voire déshydratation ou choc hypovolémique (par 3^{ème} secteur), météorisme discret, silence auscultatoire - ASP/TDM : image en arceau avec niveau liquide à chaque pied - TDM : siège et nature de l'obstacle, signes de souffrance intestinale		
OCCLUSION PAR STRANGULATION	Occlusion haute	Occlusion sur bride	= Cause la plus fréquente d'occlusion du grêle, très rarement sur bride spontanée → Toute intervention chirurgicale peut en être la cause, même de nombreuses années après	
		Hernie étranglée	= Hernie inguinale, crurale ou ombilicale, ou rarement hernie interne (obturatrice, hiatus de Winslow...) ou éventration post-opératoire - Diagnostic facile : tuméfaction douloureuse et irréductible - Plus difficile : - Petite hernie crurale chez un patient obèse - Hernie de Spiegel (hernie du bord externe du muscle grand droit)	
		Invagination intestinale	- Rare chez l'adulte, quasi-toujours sur une affection tumorale de l'intestin ou du mésentère - Fréquente chez le nourrisson, sans cause sous-jacente - Diagnostic : TDM (boudin d'invagination), laparotomie	

STRANGULATION	Occlusion basse	Volvulus du colon sigmoïde	= Le plus souvent chez le patient très âgé - Occlusion rarement complète (transit des gaz non interrompu) - Météorisme très important avec ballonnement asymétrique - ASP : image d'anse sigmoïdienne très dilatée, en arceau avec 2 niveaux de liquides, avec un colon d'amont peu dilaté - Opacification rectale (lavement, scanner) : image d'arrêt effilé, asymétrique, à raccordement obtus avec le rectum, siégeant à la jonction recto-sigmoïdienne (image en « bec d'oiseau »)
		Volvulus du caecum	- Tableau d'occlusion du grêle par strangulation : début brutal, vomissements précoces, ballonnement asymétrique, douleur de FID, fosse iliaque droite déshabillée - ASP : niveau hydro-aérique volumineux projeté sur l'hypochondre droit, dilatation du grêle - Opacification basse (lavement, scanner) : arrêt avant le caecum
OCCLUSION PAR OBSTRUCTION	- Occlusion de début progressif avec vomissements tardifs, état général longtemps conservé, météorisme diffus et important, bruits hydro-aériques conservés, voire hyper-péristaltisme - ASP : niveaux hydro-aériques nombreux		
	Phase pré-occlusive	Grêlique	- Syndrome de Koenig : douleur abdominale migratrice déclenchée par les repas, aboutissant toujours au même point et cédant brutalement avec une sensation de gargouillement associé à un bruit de filtration hydro-aérique et parfois une « débâcle » diarrhéique
		Colique	- Ralentissement du transit avec apparition/aggravation d'une constipation
	Occlusion haute		- Compression extrinsèque : tumeur pelvienne, ADP - Hématome pariétal (surdosage en anticoagulants) - Parasitose - Carcinose péritonéale - Bézoard
		Tumeur de l'intestin grêle	= Rares : - Polypes volumineux (syndrome de Peutz-Jeghers) - Adénocarcinome primitif - Autre : tumeur carcinoïde, lymphome, métastase (poumon, mélanome) - Obstruction incomplète (syndrome de Koenig) ou complète
		Iléus biliaire	= Complication rare et tardive d'une cholécystite négligée : fistule bilio-duodénale par laquelle passent un ou plusieurs calculs volumineux, bloqués par la valvule iléo-caecale - Occlusion évoluant par à-coups après un épisode douloureux-fébrile de l'hypochondre D - ASP/TDM : aérobilie (air dans les voies biliaires)
	Haute ou basse	Sténose bénigne	- Causes nombreuses : maladie de Crohn, ischémie intestinale segmentaire, lésion post-radique, endométriose, tuberculose iléo-caecale...
	Occlusion basse	Cancer colorectal	= Plus souvent sur un cancer du colon gauche ou du sigmoïde - Début progressif chez un patient > 50 ans, avec troubles du transit ou rectorragies minimes dans les mois précédents - TDM avec opacification basse : sténose courte, excentrée, avec anomalies muqueuses et angle de raccordement aigu au colon → La coloscopie en urgence est contre-indiquée en cas d'obstruction
		Fécalome	= A évoquer systématiquement, surtout chez les patients âgés, grabataires - Masse fécale dure au TR
		Syndrome d'Ogilvie	= Dilatation gazeuse de la totalité du colon et du rectum, généralement : suites d'un polytraumatisme, malades intubés-ventilés, patient âgé alité ou sous neuroleptiques - ASP/TDM : distension majeure du cadre colique sans obstacle organique
Conséquences	Occlusion mécanique simple : obstruction		- Dilatation en amont : hyper-péristaltisme, puis distension par les gaz (air dégluti, fermentation et sécrétions digestives) → hyperpression → Au niveau colique, si la valvule de Bauhin est continente (50% des cas) : distension jusqu'à la colectasie (colon transverse > 7 cm) avec risque de perforation diastatique, principalement caecale - Altération progressive de l'absorption → séquestration liquidienne dans l'intestin = 3^{ème} secteur : hypovolémie, aggravée par les vomissements et les troubles hydro-électriques - Hyperpression intraluminal → ischémie de la paroi digestive (si pression > pression capillaire) : ↗ la translocation bactérienne et le risque de perforation digestive
		Signes	- Hypovolémie : ↗ hématocrite et protidémie, voire insuffisance rénale fonctionnelle - Hyponatrémie (teneur élevée en sodium des liquides digestifs) - Alcalose métabolique (vomissements acides) - Acidose métabolique avec hyperkaliémie en cas d'ischémie - Baisse de la fonction ventilatoire (par altération du mécanisme diaphragmatique)

Conséquences	Occlusion à anse fermée (strangulation)		= D'emblée en cas de volvulus ou complique une bride en cas de capotage et torsion de l'anse d'amont Syndrome lésionnel : compression de l'axe vasculaire d'une ou plusieurs anses digestives - Stase veineuse : extravasation de plasma et de sang dans l'anse exclue et dans le péritoine - Destruction de la barrière muqueuse et prolifération bactérienne : passage d'endotoxine dans la cavité péritonéale et le réseau capillaire → risque de choc septique - Ischémie artérielle → gangrène, pouvant aboutir à une perforation et une péritonite généralisée	
	Signes		- Clinique : défense abdominale, choc, douleur très importante - Biologique : insuffisance rénale, hyperkaliémie - Scanner : signes d'ischémie intestinale → Intervention chirurgicale en urgence en présence d'un signe de gravité	
	Occlusion paralytique		= Conséquences principalement générales, d'évolution lente (en dehors d'une affection intra-abdominale aiguë : péritonite, abcès, infarctus mésentérique) - Vomissements rares, volume liquidien séquestré peu important, altération pariétale tardive et limitée - Risque faible de colectasie et, au dessus d'un certain diamètre, de zones de nécrose et de perforation	
CAT	Mise en condition	→ En urgence : - SNG en aspiration douce : ↘ l'accumulation de liquide, la distension et l'ischémie - Réhydratation et correction des troubles hydro-électrolytiques		
	Signes de gravité	- Signes de gravité : fièvre, signes de choc, signes de déshydratation, souffrance digestive, signes péritonéaux, hernie étranglée → intervention chirurgicale en urgence, sans imagerie préalable - Si besoin : résection intestinale + stomie avec rétablissement de continuité dans un 2nd temps		
	En l'absence de signe de gravité	→ TDM injecté (ou ASP de face debout/couché à défaut) + RP : niveau et mécanisme de l'occlusion		
		Occlusion haute	Complète	- Exploration chirurgicale
			Incomplète ou bien tolérée	- Test à la gastrograffine (peut lever un obstacle incomplet) + scanner - Intervention chirurgicale : si majoration des signes occlusifs ou si la gastrograffine n'atteint pas le caecum en < 6h
Occlusion basse	- Volvulus du sigmoïde → détorsion endoscopique (rectoscopie au tube rigide ou coloscopie au tube souple) - Autres cas : scanner avec opacification basse (ou lavement opaques avec ASP à défaut)			
TTT d'occlusion haute	Strangulation	Occlusion sur bride	Douleur très importante ou signe de gravité	= Chirurgie sans délai : section de la bride ± résection de l'intestin strangulé s'il est nécrosé ou de vitalité douteuse
			Occlusion bien tolérée et patient peu algique	= Désocclusion spontanée dans 2/3 des cas (ou aidée par le test à la gastrograffine) - Chirurgie si l'occlusion dure plusieurs jours (risque de dénutrition)
		Etranglement herniaire	= Intervention chirurgicale en urgence : réduction de la hernie ± résection de l'intestin si la vitalité est compromise et réparation de l'orifice herniaire (herniorraphie)	
	Obstruction	- Tumeur du grêle ou de la valvule de Bauhin : traitement chirurgical dans la majorité des cas (résection) - Iléus biliaire : - Traitement chirurgical de l'occlusion : entérotomie pour extraction du calcul - Traitement de la fistule biliaire dans un 2 nd temps - Sténose bénigne : - Occlusion incomplète, cédant au traitement médical - Intervention parfois nécessaire dans un 2 nd temps (maladie de Crohn...)		
TTT d'occlusion basse	Strangulation	Volvulus du colon pelvien	- Détorsion endoscopique ou radiologique puis mise en place d'un tube de Faucher (sonde rectale longue) pendant quelques jours, pour lavements évacuateurs du colon d'amont - Intervention à froid discutée dans un 2 nd temps : sigmoïdectomie avec anastomose colorectale	
		Volvulus du caecum	- Colectomie droite avec rétablissement immédiat de continuité par anastomose iléo-transverse	
	Obstruction	Cancer colorectal	Souffrance, colectasie	- Chirurgie en urgence : colectomie subtotale + anastomose iléo-rectale
			En l'absence de signe de gravité	- TTT médical (perfusion, SNG en aspiration) avec surveillance - Si l'occlusion ne cède pas en quelques heures : endoprothèse métallique trans-tumorale (sous contrôle endoscopique ou radiologique) ou colostomie en amont de la tumeur
		Fécalome	- Retrait manuel et avec des lavements évacuateurs	
		Syndrome d'Ogilvie	- Exsufflation endoscopique au tube de Faucher , éventuellement itératives ± Prokinétiques : néostigmine	